

中医外治法治疗慢性肠炎研究进展

★ 邱子芸¹ 宋佳¹ 郑晓南¹ 江鑫² 徐伟³ 叶菁^{1,4} (1. 江西中医药大学研究生院 南昌 330004; 2. 江西中医药大学临床医学院 南昌 330004; 3. 江西中医药大学体育健康学院 南昌 330004; 4. 江西中医药大学附属医院 南昌 330006)

[摘要] 慢性肠炎是一种长期或持续性的肠道炎症性疾病,其病情复杂多变,发病率逐年上升,给患者带来严重的身体和心理负担。目前西医的治疗方式多种多样,然而治疗效果并不理想,且存在许多不良反应和耐药性等问题。相比之下,中医外治法具有疗效持久、无副作用、个体化和综合治疗等优势,对于患者而言是一种安全可靠的治疗选择。通过查阅近年来的相关文献,对中医外治法治疗慢性肠炎的研究现状进行梳理,从中药灌肠、针灸、穴位埋线、强身健体功法等中医外治法进行分析总结其治疗效果和作用机制,发现中医外治法治疗慢性肠炎的作用机制涉及肠道菌群、炎症介质及相关信号通路调节等多个方面,这些机制协同发挥抑制肠道炎症反应、改善肠道屏障功能及调节机体免疫功能等作用,明显改善患者的生理病理状态并提高其生活质量。尽管中医外治法在慢性肠炎中已得到广泛应用和研究,但对于其治疗机制和治疗方案仍需要进一步探索和完善。例如,强身健体功法与其他治法的结合应用,从多学科综合研究强身健体功法对机体的作用机制,以期为该领域的进一步研究提供一定的参考。

[关键词] 中医外治法;慢性肠炎;综述

中图分类号: R256.34 **文献标志码:** A

慢性肠炎是一类包括溃疡性肠炎、放射性肠炎及慢性细菌性肠炎在内的肠道炎症性疾病,中医学将其归于“泄泻”“痢疾”及“肠癖”范畴^[1]。慢性肠炎常由外邪侵袭、饮食不当、脾胃虚弱等多种因素导致肠胃功能失司而引发腹痛、腹泻等消化系统症状^[2]。慢性肠炎的西医治疗主要包括药物治疗、手术治疗和饮食调整等,其中,药物治疗是最主要的治疗方式,常用药物包括氨基水杨酸类、糖皮质激素、免疫抑制剂等,但这些药物都有一定的副作用和难以治愈的缺点,且治疗效果和疾病复发的风险因人而异^[3-4]。而中医外治法注重人体整体平衡及个体化治疗,利用中药、针灸及运动等手段来治疗慢性肠炎,具有疗效高、无副作用、不易复发等优点,成为治疗慢性肠炎的重要手段之一^[5]。慢性肠炎的发病率在世界范围内持续上升,且逐渐低龄化^[6],本文探讨了不同的中医外治法对于慢性肠炎的治疗效果和作用机制,以期为慢性肠炎的治疗提供更加全面和科学的视角,探索更多的治疗方案。

1 中药灌肠

中药灌肠法是通过肛门直肠给药,使药液直达病灶以充分发挥药效的常用中医外治法之一,此疗

法具有操作简单、给药安全及药物利用率高等特点,深受广大患者的认可^[7]。中医理论认为,肺与大肠相表里^[8],由经络相络属,其生理功能和病理变化相互影响,很好地解释了中医理论体系中的整体观念。根据肺朝百脉的生理功能,药物由直肠快速吸收后,经血液循环向上流经于肺,再从肺沿百脉输送至周身,达到治疗目的^[9]。

当代医学研究证明,中药灌肠在慢性肠炎的治疗中具有积极的疗效,可有效缓解肠道炎症,促进肠黏膜修复。宋洪杰^[10]研究发现,在对照组(常规 rhGM-CSF 治疗)的基础上配合白头翁汤灌肠,可快速缓解放射性直肠炎患者腹泻、腹痛及便血等症状,观察组有效率为 91.67%,明显高于对照组的 72.92%。赵梦月等^[11]研究发现,分别给予美沙拉秦和白芍散灌肠治疗的溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)大鼠,其精神状态、大便情况及结肠组织病理状况均得到明显改善。经药理研究分析,白芍散中的白及多糖、黄酮类及酚类等成分可能通过调控相关基因表达和信号通路,降低促炎因子活性,提高活性氧代谢,从而促进肠黏膜修复,缓解肠道损伤^[12-13]。施丽婕等^[14]研究发现,化癥通阳方可能通过调节 UC 大鼠肠道中乳杆菌属和阿克

基金项目:江西省体育局体育科研项目(2022056)。

通信作者:叶菁,博士,副教授。E-mail: 39593872@qq.com。

曼氏菌属的相对丰度,以促进肠道黏膜屏障的完整性,抑制肠道炎症反应及代谢紊乱的发生。Lin 等^[15]研究发现清白汤灌肠,可能通过抑制 NF- κ B 信号传导和 Notch 活性来保护紧密连接蛋白、增强肠道屏障功能并降低肠黏膜的通透性,从而缓解 UC 小鼠肠黏膜炎症。

2 针刺

针刺是将针体快速刺入皮下,通过提插捻转的手法来刺激经络上的穴位,从而达到疏通经络、调整阴阳、调和气血、扶正祛邪等治疗目的的一种方法。在临床实践中,一些经典穴位如天枢、上巨虚、合谷及关元等被广泛应用于针刺疗法,这些穴位的选取重点考虑了其在健脾和胃、通腑降气、推动气血等方面的功效。

大量研究已证实针刺治疗对慢性肠炎具有显著的疗效,其可能通过调节促炎因子含量、调控凋亡因子及相关蛋白表达等方式改善症状和组织病理学评分。王德芳等^[16]研究发现,针刺联合黄芩汤化裁方治疗可显著降低血清促炎因子含量,临床总有效率明显高于常规西药治疗。李晗等^[17]对 UC 大鼠分别进行针刺、隔药灸、VD 灌胃治疗,结果显示,各治疗组大鼠的组织病理学评分均明显下降,研究发现针刺可能通过调节 VDR 及下游 p53 信号通路中 p53、PUMA 及 Caspase-3 相关蛋白的表达,以减轻肠道黏膜损伤。Qi 等^[18]采用 iTRAQ 技术分析差异表达蛋白的生物学功能,研究发现针灸可以通过调控与氧化磷酸化相关蛋白的表达,以调节免疫相关途径,减轻 UC 大鼠的炎症反应。

3 艾灸

《名医别录》有言:“艾味苦,微温,无毒,主灸百病。”艾条依靠燃烧使局部温热,以刺激人体穴位,其产生的热量通过经络系统传导至全身,从而达到调和阴阳气血、扶正祛邪等治疗目的,故临床上大多使用艾条进行局部治疗。

近年来,大量研究表明,艾灸治疗慢性肠炎可通过调节炎症介质浓度、肠道屏障相关蛋白表达及肠道微生物群落丰度等,发挥抗炎和修复作用。林江燕等^[19]使用白头翁汤加减配合艾灸治疗 UC,总有效率明显高于常规西药治疗,研究组总有效率为 95.83%,对照组为 83.33%。穆韵浓等^[20]研究发现艾灸神阙穴能够升高结肠组织中紧密连接蛋白 ZO-1、Occludin 的表达,并降低血清中 IL-6 和 TNF- α 炎症因子的表达,从而恢复肠道屏障稳态,有效缓解 UC 症状。有研究发现,艾灸治疗可以通

过调节肠道菌群的结构(如降低普雷沃氏菌的丰度)、下调炎症细胞因子及上调抗炎细胞因子的表达,以恢复 UC 大鼠的免疫功能,改善肠道黏膜炎症^[21]。Bao 等^[22]研究发现艾灸可能通过减少海马神经元和小胶质细胞的过度激活,以抑制 KP 代谢,从而有利于改善克罗恩大鼠肠道炎症、代谢紊乱及抑郁行为。

4 穴位埋线

穴位埋线是针灸疗法的一种延伸和发展,主要用可吸收的羊肠线或药线埋入相应的穴位,以线代针长期留置体内,持续刺激腧穴,从而加强治疗效果的一种方法。

Yu 等^[23]根据 Meta 分析和试验序贯分析的研究结果,发现穴位埋线治疗 UC 的临床疗效优于常规西药(如美沙拉嗪、柳氮磺吡啶),并且基于国家食品药品监督管理局公布的数据(美沙拉嗪引起的头痛率为 14%,柳氮磺吡啶引起的恶心率为 19%,穴位埋线无明显不良反应),推测穴位埋线发生不良事件的风险可能低于常规西药。刘森等^[24]采用随机分组的方法将 UC 患者分为观察组(穴位埋线治疗)和对照组(穴位针刺治疗),两组均选取大肠俞、脾俞、中脘及天枢穴。结果显示,观察组总有效率(87.50%)明显高于对照组(65.00%),观察组的 DAI 评分、结肠镜表现评分及症状改善程度均显著优于对照组,提示穴位埋线能够加快炎症的消退,促进肠道溃疡面的愈合。刘朝霞等^[25]研究发现 UC 大鼠经穴位埋线治疗后,其一般状况、结肠组织炎性浸润及充血水肿程度均明显改善,血清 IL-18、IL-1 β 、IFN- γ 水平均明显下降。基于以上研究结果,发现穴位埋线可能通过调节免疫系统、抑制炎症反应、促进肠道组织修复等方式,发挥治疗作用。

5 穴位贴敷

《本草纲目》中描述了治疗大腹水肿的贴敷方法:“以赤根捣烂,入元寸,贴于脐心。”穴位贴敷^[26]根据“经脉所过,主治所及”的原理,利用药物刺激,直接作用于人体相应穴位,并将药效输送至人体相应部位,从而起到调达气血、调和阴阳、扶正固本的作用。

相关研究发现穴位贴敷具有激活免疫细胞、调节炎症因子水平及改善局部新陈代谢的作用,因而广泛应用于消化系统疾病^[27]。张雪等^[28]对治疗组 UC 患者采用中药汤剂联合穴位贴敷进行治疗,结果显示,治疗组血清炎症因子水平及淋巴细胞值明显下降,免疫功能指标水平显著上升,且治疗组

相较于对照组的疗效更佳。娄余等^[29]根据经络具有“联系上下,沟通表里”的生理功能,进行穴位贴敷与非穴位贴敷治疗的对比研究,观察 UC 大鼠的结肠病理损伤情况。结果显示,穴位贴敷组大鼠结肠病理损伤改善更明显,其结肠组织 NF- κ B p65、IKK α 蛋白表达及血清促炎因子含量均下降更显著。

6 其他外治疗法

除了上述外治法,还有穴位按摩、耳穴压豆、气功等疗法。穴位按摩和耳穴压豆均通过压力刺激人体特殊穴位,达到疏通经脉、调气和血及扶正祛邪的治疗目的^[30]。气功^[31]是通过练功以调养身心,坚持积极的运动锻炼,如八段锦、太极、易筋经等,按照科学的方法进行练功和调息,有助于调整体内阴阳二气,达到“阴平阳秘”的最佳状态。

在治疗慢性结肠炎的临床试验中发现,穴位按摩和耳穴压豆疗法在改善患者粪便性状、症状积分、肠镜黏膜 Baron 积分等方面显示出积极的效果,同时对焦虑、抑郁及生活质量等方面具有改善作用^[32-33]。孟晓旭等^[34]研究发现,采用八段锦进行训练可纠正患者的负性情绪,利于患者增进自我效能感,提高生活质量。谢峰^[35]研究发现运动锻炼有助于调整体内炎症因子和免疫功能,改善肠道内环境,加快 UC 患者机体的恢复速度。一项关于运动强度的研究表明,不同强度的运动可通过减少促炎细胞因子释放、改变肠道微生物群及改善整体免疫能力等方式,对炎症性结肠炎患者的肠道起到保护作用^[36]。Koutouratsas 等^[37]研究了各种形式的运动对不同人群及动物中肠道微生物群组成、功能及多样性的影响,重点分析了体育锻炼在炎症性肠病中恢复肠道生态平衡的可能机制(如调节免疫细胞功能、调控下丘脑—垂体—肾上腺轴应激反应),并表示采用个性化运动方案治疗该疾病具有很好的抗炎作用。

7 小结与展望

慢性结肠炎极易复发且很难根治,针对该病的治疗方法一直在不断探索和创新。中药灌肠以“因人制宜”的治则为依据,辨证采用合适的方药,作用于肠道局部至整体,以达到标本兼顾的治疗目的。针灸疗法运用“以点带面,内外联动”的整体施治原则,充分发挥中医特色治疗优势。健身功法着重突出形、神、息三者合一,其中调形以强筋壮骨、调神以宁心安神、调息以和气养血,对慢性结肠炎患者的康复治疗具有积极意义。近年来,

大量研究已证实中医外治法对改善患者心理状态、平衡体内阴阳、增强机体免疫功能等方面具有重要的调节作用,进一步丰富治疗慢性结肠炎的理论体系。

综上,针对慢性结肠炎的中医外治法具有广阔的应用前景,尽管如此,目前的研究还存在一些值得关注的问题:(1)大多数中医治疗采用联合治疗方式,难以准确反映中医单项治疗的效果,建议加强该方面的研究,以排除不必要的治疗,实现最优组合。(2)缺少对远期疗效和疾病复发率的研究,建议加强这些方面的观察,以便推测出合适的时间段进行干预,延长疗效。(3)缺乏将强身健身功法应用于慢性结肠炎的研究,建议增加相关功法的研究,探讨其对机体的作用机制,寻找更多高效的运动锻炼方式以提高疗效。(4)大多数对诱导后的动物进行干预治疗,建议采用“治未病”的思路进行预防慢性结肠炎的研究,即在动物诱导前或诱导时进行干预,探索出更好的预防措施,以减少疾病的发生。谨希望随着中医外治法相关研究的不断深入,筛选出更有效的治疗途径,探索出最佳组合的治疗方案,切实提高慢性结肠炎的治疗效果。

参考文献

- [1] 刘毅,胡娇娇,潘杰,等.升阳除湿汤加减对慢性结肠炎疗效及可能机制研究[J].世界中医药,2021,16(3):467-471,476.
- [2] 田晓鹏,陈珍珍,赵丹,等.基于治中焦如衡理论谈泄泻治疗[J].光明中医,2023,38(4):742-744.
- [3] Brenner E J, Ungaro R C, Geary R B, et al. Corticosteroids, But Not TNF Antagonists, Are Associated With Adverse COVID-19 Outcomes in Patients With Inflammatory Bowel Diseases: Results From an International Registry[J].Gastroenterology, 2020, 159(2):481-491, e3.
- [4] Zheng M, Han R, Yuan Y, et al. The role of Akkermansia muciniphila in inflammatory bowel disease: Current knowledge and perspectives[J]. Front Immunol, 2023, 13: 1089600.
- [5] Luo H, Chen Y, Zhang Y, et al. External treatment of traditional Chinese medicine for radiation enteritis: A protocol for systematic review and meta-analysis[J]. Medicine, 2021, 100(21): e26014.
- [6] Kuenzig M E, Fung S G, Marderfeld L, et al. Twenty-first Century Trends in the Global Epidemiology of Pediatric-Onset Inflammatory Bowel Disease: Systematic Review[J].Gastroenterology, 2022, 162(4): 1147-1159.
- [7] 张颖,韩雪迎.保留灌肠治疗放射性直肠炎时插管深度及体位的探讨[J].中国肛肠病杂志,2022,42(8):55-56.
- [8] 张国磊,王宇立,诸君,等.基于“肺与大肠相表里”理论探讨肠道菌群对肺癌影响[J].现代中医临床,2023,30(1):90-93.
- [9] 周春慧,韩晓璐,李蒙,等.基于直肠给药系统的研究和最新进展[J].药学研究,2022,41(2):107-112.
- [10] 宋洪杰.白头翁汤灌肠疗法联合 rhGM-CSF 在宫颈癌患者放疗后放射性直肠炎中的疗效分析[J].世界复合医学,2022,8(7):111-

- 115.
- [11] 赵梦月, 孙晓健, 王宏昌, 等. 基于动物实验和网络药理学研究白竭散保留灌肠治疗溃疡性结肠炎的作用机制 [J]. 河北中医, 2021, 43(11): 1866–1873, 1932.
- [12] Zhang Q, Qi C, Wang H, et al. Biocompatible and degradable *Bletilla striata* polysaccharide hemostasis sponges constructed from natural medicinal herb *Bletilla striata*[J]. *Carbohydrate Polymers*, 2019, 226: 115304.
- [13] Rodríguez-García C, Sánchez-Quesada C, J Gaforio J. Dietary Flavonoids as Cancer Chemopreventive Agents: An Updated Review of Human Studies[J]. *Antioxidants*, 2019, 8(5): 137–137.
- [14] 施丽婕, 刘苏仪, 于潇, 等. 化痰通阳方对溃疡性结肠炎模型大鼠肠道菌群和氨基酸代谢的影响 [J]. 中医杂志, 2020, 61(19): 1731–1737.
- [15] Lin J C, Wu J Q, Wang F, et al. QingBai decoction regulates intestinal permeability of dextran sulphate sodium-induced colitis through the modulation of notch and NF- κ B signalling[J]. *Cell Prolif*, 2019, 52(2): e12547.
- [16] 王德芳, 赵明, 李晓艳. 针刺结合黄芩汤化裁方治疗溃疡性结肠炎活动期(湿热蕴结证)的疗效观察 [J]. 中医药导报, 2022, 28(2): 71–75.
- [17] 李晗, 李昆珊, 吴璐一, 等. 针灸对溃疡性结肠炎大鼠维生素 D 受体及 p53 信号通路调节作用的研究 [J]. 世界中医药, 2020, 15(15): 2259–2263, 2270.
- [18] Qi Q, Zhong R, Liu Y N, et al. Mechanism of electroacupuncture and herb-partitioned moxibustion on ulcerative colitis animal model: A study based on proteomics[J]. *World J Gastroenterol*, 2022, 28(28): 3644–3665.
- [19] 林江燕, 李龙, 章健. 白头翁汤加减配合艾灸治疗湿热蕴结型慢性结肠炎的疗效 [J]. 临床合理用药杂志, 2022, 15(33): 73–76.
- [20] 穆韵浓, 赵百孝, 任俊逸, 等. 艾灸神阙穴对溃疡性结肠炎小鼠血清促炎因子及肠黏膜紧密连接蛋白的影响 [J]. 中国中医急症, 2020, 29(6): 952–956.
- [21] Qi Q, Liu Y N, Lv S Y, et al. Gut microbiome alterations in colitis rats after moxibustion at bilateral Tianshu acupoints[J]. *BMC Gastroenterol*, 2022, 22(1): 62.
- [22] Bao C, Huang J, Wu H, et al. Moxibustion alleviates depression-like behavior in rats with Crohn's disease by inhibiting the kynurenine pathway metabolism in the gut-brain axis[J]. *Front Neurosci*, 2022, 16: 1019590.
- [23] Yu Y, Zhou M, Tong Y, et al. Meta-analysis and trial sequential analysis of acupoint catgut embedding in the treatment of ulcerative colitis: Acupoint catgut embedding treating ulcerative colitis[J]. *Medicine*, 2022, 101(47): e30945.
- [24] 刘森, 杜强, 毛刚, 等. 基于“俞募配穴”理论穴位埋线疗法结合常规治疗对溃疡性结肠炎的疗效研究 [J]. 医学信息, 2022, 35(23): 143–146.
- [25] 刘朝霞, 李玳玳, 许晓男, 等. 穴位埋线调控 NLRP3 炎症小体及 IL-27 表达对溃疡性结肠炎大鼠的黏膜保护作用 [J]. 针灸临床杂志, 2022, 38(9): 66–72.
- [26] 朱卫丰, 王雅琦, 吴文婷, 等. 中药穴位贴敷的现代研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2023, 48(3): 579–587.
- [27] 田硕, 苗明三. 基于神经-内分泌-免疫网络探讨中药外用作用机制——“三微调平衡” [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(4): 6–12.
- [28] 张雪, 屈银宗. 加味附子理中汤联合穴位敷贴治疗溃疡性结肠炎临床观察 [J]. 中医临床研究, 2022, 14(28): 121–124.
- [29] 娄余, 肖运婷, 朱莹, 等. 基于 NF- κ B 信号通路的溃结宁膏穴位敷贴对溃疡性结肠炎大鼠结肠黏膜炎症反应的影响 [J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(4): 75–80.
- [30] 石冬梅. 耳穴埋豆联合穴位按摩治疗乳腺癌化疗后所致恶心呕吐的研究进展 [J]. 中医药临床杂志, 2021, 33(5): 999–1002.
- [31] 严军, 钟袁源, 张安然, 等. 健身气功在改善和促进人体健康方面的应用研究进展 [J]. 江西中医药大学学报, 2019, 31(2): 117–120.
- [32] 张媛媛, 张雪兰, 关清, 等. 引气归元穴穴位按摩联合脐灸对脾肾阳虚型溃疡性结肠炎疗效的影响 [J]. 现代中西医结合杂志, 2022, 31(18): 2587–2591.
- [33] 陈红霞, 仇珏, 黄河, 等. 耳穴按摩配合耳穴压豆对溃疡性结肠炎患者心理状态的影响 [J]. 中医外治杂志, 2019, 28(2): 18–19.
- [34] 孟晓旭, 崔继燕, 王芳. 基于移动管理系统的延续护理联合中高架势八段锦对溃疡性结肠炎患者的负性情绪、生活质量和自我效能感的影响 [J]. 海南医学, 2020, 31(18): 2444–2447.
- [35] 谢峰. 高强度间歇性运动联合药物治疗溃疡性结肠炎患者的效果及对血清促炎因子、免疫功能的影响 [J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(31): 155–156.
- [36] Ordille A J, Phadtare S. Intensity-specific considerations for exercise for patients with inflammatory bowel disease[J]. *Gastroenterol Rep*, 2023, 11: goad004.
- [37] Koutouratsas T, Philippou A, Kolios G, et al. Role of exercise in preventing and restoring gut dysbiosis in patients with inflammatory bowel diseases: A review[J]. *World J Gastroenterol*, 2021, 27(30): 5037–5046.

(收稿日期: 2023-03-07) 编辑: 宋超